Universidade Federal da Bahia
Instituto de Saúde Coletiva
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Mestrado Profissional em Saúde Coletiva área de concentração:
Gestão de Sistemas de Saúde

Modalidades de Aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica pelos Municípios da Bahia: Uma Análise Comparativa

Orientando: José Geraldo Peixoto Júnior

Orientadora: Profª. Drª. Alcione Brasileiro Oliveira

Dissertação de mestrado profissional apresentado ao programa de pós-graduação em saúde coletiva.

Salvador
2025

JOSÉ GERALDO PEIXOTO JÚNIOR

MODALIDADES DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PELOS MUNICÍPIOS DA BAHIA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Saúde Coletiva.

Orientadora: Profª. Drª. Alcione Brasileiro Oliveira

Salvador
2025

Ficha Catalográfica
Elaboração Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

P739m Peixoto Júnior, José Geraldo.

Modalidades de aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica pelos municípios da Bahia: uma análise comparativa / José Geraldo Peixoto Júnior. -- Salvador: J.G.Peixoto Júnior, 2025.

53f.: il.

Orientadora: Profa. Dra. Alcione Brasileiro Cunha.

Dissertação (mestrado profissional) – Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia.

1. Assistência Farmacêutica. 2. Serviços de Assistência Farmacêutica. 3. Financiamento Governamental. 4. Componente Básico da Assistência. 5. Licitação. 6. Medicamentos para a Atenção Básica. I. Título.

CDU 614.2

Universidade Federal da Bahia
Instituto de Saúde Coletiva – ISC
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Modalidade Profissional

José Geraldo Peixoto Júnior

Modalidades de Aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica pelos Municípios da Bahia: Uma Análise Comparativa.

A Comissão Examinadora abaixo assinada, aprova a Dissertação, apresentada em sessão pública ao Programa de Pós-Graduação do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.

Data de defesa: 19 de maio de 2025

Banca Examinadora:

Profa. Alcione Brasileiro Oliveira – ISC/UFBA

Profa. Dra. Ana Carla Freitas Fonseca -SESAB

Profa. Dra. Yara Oyram Ramos Lima- ISC/UFBA

Salvador
2025

RESUMO

O tratamento medicamentoso é uma ferramenta muito importante na promoção, proteção e recuperação da saúde e isso pode ser observado tanto na presença massiva da indústria farmacêutica na área da saúde quanto nas normatizações do Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, que diz que todo cidadão tem direito a “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.

Para garantir esse direito, o Brasil adotou um modelo de Assistência Farmacêutica em consonância com as melhores práticas definidas pela OPAS: relação de medicamentos essenciais, uso racional de medicamentos, acesso aos medicamentos e garantia de financiamento. O presente estudo objetivou analisar as modalidades de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica adotados pelos municípios do estado da Bahia.

Para isso, foram utilizados os bancos de dados disponíveis no estado da Bahia, nos quais são registradas as diversas modalidades de aquisição de medicamentos pelos municípios, nos anos de 2022 e 2023: licitação direta feita pelo município, compra pelo município utilizando o Registro de Preço Compartilhado (RPC) e transferência de medicamentos do estado para os municípios.

Após o tratamento dos dados foram identificadas 55 especialidades farmacêuticas (EF) que atendiam aos critérios de análise.

Observou-se que o Estado obteve o menor preço médio em 34 EF, sendo seguido do RPC com 12 EF e a compra pelo município com 09 medicamentos. Analisando por macrorregião, verificou-se o menor preço médio em 10 EF compradas pela oeste, seguida das leste e norte com 08 EF cada uma.

Os resultados indicam que os melhores preços médios concentraram-se no Estado, mas os dados disponibilizados foram insuficientes para asseverar essa superioridade. O Registro de Preço Compartilhado, por sua vez, mostrou-se uma alternativa vantajosa, oferecendo preços competitivos e um processo de compra simplificado para os municípios.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Serviços de Assistência Farmacêutica; Financiamento Governamental; Financiamento Público; Componente Básico da Assistência Farmacêutica; Licitação; Medicamentos para a Atenção Básica.

ABSTRACT

Drug treatment is a very important tool in promoting, protecting and restoring health, and this can be seen both in the massive presence of the pharmaceutical industry in the health sector and in the regulations of the Unified Health System (SUS), for example, the Organic Health Law, Law No. 8,080/1990, which states that every citizen has the right to “comprehensive therapeutic assistance, including pharmaceutical assistance”.

To guarantee this right, Brazil adopted a Pharmaceutical Assistance model in line with the best practices defined by PAHO: list of essential medicines, rational use of medicines, access to medicines and guaranteed financing. This study aimed to analyze the methods of acquiring medicines from the Basic Component of Pharmaceutical Assistance adopted by the municipalities of the state of Bahia.

For this purpose, the databases available in the state of Bahia were used, which record the various methods of drug acquisition by municipalities in 2022 and 2023: direct bidding by the municipality, purchase by the municipality using the Shared Price Registry (RPC), and transfer of drugs from the state to the municipalities.

After processing the data, 55 pharmaceutical specialties (PS) that met the analysis criteria were identified.

It was observed that the state obtained the lowest average price in 34 PS, followed by the RPC with 12 PS and purchase by the municipality with 09 drugs. Analyzing by macro-region, the lowest average price was found in 10 PS purchased by the west, followed by the east and north with 08 PS each.

The results indicate that the best average prices were concentrated in the state, but the data available were insufficient to assert this superiority. The Shared Price Registry, in turn, proved to be an advantageous alternative, offering competitive prices and a simplified purchasing process for municipalities.

Keywords: Pharmaceutical Services; Pharmaceutical Service; Financing, Government; Public Financing; Basic Component of Pharmaceutical Assistance; Competitive Bidding; Medications for Primary Health Care.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 6

2. OBJETIVOS..... 12

2.1. OBJETIVO GERAL..... 12

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 12

3. REFERENCIAL TEÓRICO..... 13

3.1. SISTEMAS UNIVERSAIS DE SAÚDE E A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.. 13

3.2. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO BRASIL..... 15

3.3. FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA..... 17

3.4. MODALIDADES DE COMPRA NO SETOR PÚBLICO..... 19

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO..... 21

4.1. TIPO DE ESTUDO..... 21

4.2. FONTE E COLETA DE DADOS..... 21

4.3. VARIÁVEIS UTILIZADAS..... 22

4.4. TRATAMENTO DOS DADOS..... 23

4.5. INDICADORES UTILIZADOS..... 24

4.6. ANÁLISE DOS DADOS..... 25

5. ASPECTOS ÉTICOS..... 27

6. RESULTADOS..... 28

6.1. DADOS CONSOLIDADOS EM NÍVEL ESTADUAL..... 28

6.2. DADOS CONSOLIDADOS POR MACRORREGIÃO DE SAÚDE..... 35

7. DISCUSSÃO..... 42

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 48

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 50

1. INTRODUÇÃO

O tratamento medicamentoso na prevenção de agravos e recuperação da saúde é uma ferramenta relevante, o que pode ser constatado tanto pela observação simples da presença massiva da indústria farmacêutica na área da saúde, e seus desdobramentos no cotidiano da sociedade, quanto nas normatizações do Sistema Único de Saúde (SUS), que desde a Constituição Federal (Brasil, 1988) dá destaque ao medicamento.

No arcabouço normativo, após a Constituição de 1988, temos a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, deixando expresso que as pessoas têm direito a "assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica" (Brasil, 1990), e já no final da década de 90 é publicada a Política Nacional de Medicamentos (Brasil, 1998), que direciona para o uso seguro e racional do medicamento, definindo objetivos claros para serem alcançados por meio da Assistência Farmacêutica.

Seguindo o processo de fortalecimento e institucionalização da Assistência Farmacêutica, foi publicada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, em 2004, destacando o medicamento como insumo essencial de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, em consonância com a Política Nacional de Medicamentos, fortalecendo tanto o acesso quanto o uso racional do medicamento (Conselho Nacional de Saúde, 2004).

O modelo de Assistência Farmacêutica regulamentado no Brasil está de acordo com o que propõe a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a qual define que uma política farmacêutica nacional deve buscar assegurar: acesso a medicamentos por parte de toda população, de acordo com os princípios de eqüidade e justiça social que devem caracterizar as políticas do setor saúde; a disponibilidade de medicamentos com qualidade, segurança e eficiência terapêutica; e o uso terapeuticamente racional e economicamente eficiente dos medicamentos por parte de profissionais de saúde e usuários (Organização Pan-Americana da Saúde, 2005).

Como a garantia do direito de acesso ao medicamento não se exerce sem o respectivo financiamento, desde 1999, o Ministério da Saúde lançou as bases desse

financiamento, que iniciou com a Portaria GM/MS nº 176/1999 (Brasil, 1999), a qual já previa que o financiamento seria tripartite, município, estado e União, além de condicionar o repasse da União à execução das contrapartidas dos estados e municípios.

Desde então, o financiamento da Assistência Farmacêutica tem sido garantido por meio de transferências fundo a fundo, aumentando gradativamente a relação de medicamentos cobertos pelo financiamento da Assistência Farmacêutica e a descentralização da gestão, dando maior autonomia para os estados e os municípios. A primeira Portaria que regulamentou o financiamento da Assistência Farmacêutica, Portaria GM nº 16 de 14 de dezembro de 2000, previu 19 (dezenove) itens a serem pactuados (Brasil, 2001), atualmente a Portaria de Consolidação nº 06/2017 autoriza a compra de mais de 300 (trezentas) especialidades farmacêuticas, que estão listadas no Anexo I da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Saúde, 2022).

Apesar do financiamento ser tripartite, a União concedia aos estados e municípios algumas possibilidades na compra dos medicamentos, como: Atas Estaduais de Registro de Preços, consórcios de saúde, transferência da parte do estado em medicamentos para os municípios (Brasil, 2013).

Nas atas Estaduais de Registro de Preço, o estado realiza todo o trâmite administrativo da licitação e o município manifesta, em tempo oportuno, o interesse de adquirir os medicamentos licitados pelo estado (Brasil, 2021).

Já o consórcio de saúde é caracterizado pela união de municípios, na qual todos assinam um contrato para a criação de uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, que será regido por um protocolo de intenções, o qual define, entre outras coisas, os municípios participantes, o prazo de duração do consórcio, a área de atuação e finalidade. O consórcio criado fará a compra de medicamentos de forma centralizada e distribuirá para os municípios consorciados (Brasil, 2005).

Na terceira modalidade, o estado assume a responsabilidade de realizar a compra de medicamentos, de forma centralizada, e, em vez de transferir o recurso

da contrapartida estadual para o Fundo Municipal de Saúde (FMS), o estado transfere em medicamentos o valor devido aos municípios.

Os diversos arranjos possíveis foram experimentados nos estados e municípios brasileiros. Numa análise de 600 municípios, utilizando dados coletados na Pesquisa Nacional Sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) de julho de 2014 a maio de 2015, Faleiros *et al* observaram a distribuição dos modelos possíveis de financiamento da Assistência Farmacêutica e concluíram que 11% do municípios tinham o recurso totalmente centralizado no estado, 31% tinham o recurso totalmente descentralizado para o município, 54% tinham os recursos parcialmente descentralizados para os municípios e 4% adotavam outro modelo (Faleiros et al., 2017).

O estado de Minas Gerais, por exemplo, adotou inicialmente o modelo centralizado para aquisição de medicamentos, a partir de 2016, começou a adotar um modelo mais descentralizado, estimulando a compra de medicamentos por meio de Ata de Registro de Preço Estadual e repassando os recursos da União e do estado para os FMS (Dibai et al., 2023).

Já em Santa Catarina, foi adotado um outro modelo, a partir de 2008, os municípios da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), passaram a utilizar o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMMVI) para aquisição de medicamentos (Amaral; Blatt, 2011).

Apesar de a descentralização ser um princípio organizativo do SUS, que deve ser perseguido e estimulado por todos os gestores, não significa que seja um movimento simples e sem riscos, porque, da mesma forma que os municípios estão mais próximos das necessidades e possuem capacidade de resposta mais rápida, também possuem uma estrutura administrativa e de financiamento mais limitadas do que o estado, o que expõe os munícipes ao subfinanciamento da Assistência Farmacêutica e ao risco de desassistência.

Pontes MA *et al* analisaram o valor investido no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) por 960 municípios brasileiros entre julho de 2013 e junho de 2014 e concluíram que 73% dos municípios não aplicaram o mínimo no

CBAF e que os municípios com gestão “totalmente descentralizada aplicam, em média, menos do que os municípios com gestão total ou parcialmente centralizada no estado” (Pontes et al., 2017), apontando que a simples transferência do recurso financeiro para a gestão municipal não é o caminho mais seguro.

A experiência de Minas Gerais mostrou-se mais efetiva, na qual a descentralização do recurso foi acompanhada do suporte da Secretaria Estadual de Saúde, que coordenou, executou e disponibilizou Ata de Registro de Preço Estadual para os municípios adquirirem medicamentos (Dibai et al., 2023).

Dibai CAO *et al* compararam os custos de duas estratégias de abastecimento de medicamentos: centralizada no estado (Minas Gerais) e descentralizada no Município, em compras realizadas em 2015, antes da descentralização que ocorreu em 2016, e em 2018, após a descentralização. Foram identificadas 117 especialidades farmacêuticas adquiridas tanto em 2015 quanto em 2018. O custo da compra centralizada no estado, em 2015, agregava o valor dos medicamentos e as despesas referentes ao recebimento, armazenamento e distribuição, o que totalizou R$ 154.364.969,62, já em 2018, quando a compra estava descentralizada nos municípios, usando as Atas de Registro de Preço Estadual, a logística ficava sob a responsabilidade do fornecedor do medicamento, portanto embutida no preço final do produto, e o custo total foi de R$ 132.076.766,99, representando uma economia de R$ 22.288.202,63, equivalente a 14% do total (Dibai et al., 2023). Sugerindo que a descentralização dos recursos, com apoio técnico e administrativo do estado, tende a ser mais eficiente.

No estado da Bahia, o modelo regulamentado pela Resolução CIB nº 90/2011, inicialmente, proporcionou pouca autonomia aos municípios e concentrou recursos no estado, de maneira que toda a contrapartida estadual ficou controlada pelo estado e ainda reteve sob a sua administração a contrapartida da União de 285 municípios, representando 68% dos 417 municípios baianos (Bahia, 2011a). Em outras palavras, o estado em vez de transferir os recursos para os municípios, a fim de que estes pudessem comprar diretamente os medicamentos conforme suas necessidades, concentrou os recursos consigo e transferia o valor equivalente em medicamentos. Essa conduta gerou uma restrição para os municípios, porque o

elenco disponibilizado pelo estado continha 160 especialidades farmacêuticas, enquanto o elenco de medicamentos que poderiam ser adquiridos com os recursos da Assistência Farmacêutica continha 347 itens, mais de 2 vezes maior do que o elenco oferecido pelo estado (Bahia, 2011b).

Entretanto, o estado da Bahia seguiu com mudanças graduais no modelo de financiamento do CBAF, e em 2015, por meio das Resoluções CIB nº 12 e 74/2015, foi ampliado, de 132 para 281, o número de municípios que passaram a receber a contrapartida federal depositada diretamente no FMS (Bahia, 2015a, 2015c). No 1º semestre de 2021, foi dado mais um passo em direção ao fortalecimento da autonomia municipal por meio da Resolução CIB nº 152/2020 de 11 de setembro de 2020. Essa Resolução mudou a forma de repasse do recurso federal do CBAF e pactuou a transferência fundo a fundo, o recurso federal passou a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde direto para o FMS dos 417 municípios da Bahia, mas ainda reteve a contrapartida estadual e continuou executando a parte do estado por meio de envio de medicamentos para os municípios (Bahia, 2020a).

Em 2022, o estado pactuou na Comissão Intergestores Bipartite que 08, dos 417 municípios, passariam a receber o recurso estadual mediante repasses mensais do fundo estadual de saúde aos FMS (Bahia, 2022a). Em abril de 2024, com a Resolução CIB nº 118/2024, o estado seguiu caminhando na direção do fortalecimento da municipalização da saúde, quando publicou um cronograma para transferir, de acordo com o interesse e requerimento dos entes interessados, a contrapartida estadual diretamente para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, iniciando na publicação da Resolução e concluindo em maio de 2025, data em que todos os municípios, independente de requerimento e qualificação, passariam a gerenciar a contrapartida estadual do CBAF. (Bahia, 2024)

Além das mudanças executadas no modelo de transferência dos recursos estaduais do CBAF, o estado da Bahia, em 2020, inaugurou, com a publicação da Resolução CIB nº 153/2020, o Registro de Preço Compartilhado (RPC), modalidade na qual o estado se responsabiliza por realizar as licitações e as Atas de Registro de Preços, às quais o município poderá manifestar interesse de adesão e comprar os medicamentos diretamente dos fornecedores licitados pelo estado (Bahia, 2020b).

Diante dos avanços legais adotados pelo estado da Bahia, cabe refletir se adotar um modelo no qual toda a contrapartida estadual é depositada diretamente no FMS e oferecer aos municípios a possibilidade de adquirir medicamentos por meio Registro de Preços Compartilhado, permitirá que os municípios consigam adquirir uma quantidade maior de medicamentos com o mesmo recurso?

Desse modo, esse estudo pretende analisar os avanços no processo de financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no estado da Bahia, buscando responder se a estratégia adotada é benéfica aos municípios.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Analisar as modalidades de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica adotadas pelos municípios do estado da Bahia.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparar o custo dos medicamentos para o conjunto de municípios no estado da Bahia entre as diferentes modalidades de compra nos anos de 2022 e 2023.

Comparar o custo de medicamentos selecionados segundo macrorregiões de saúde do estado da Bahia nas diferentes modalidades de compra nos anos de 2022 e 2023.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. SISTEMAS UNIVERSAIS DE SAÚDE E A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, estando alicerçado, conforme previsto na Constituição Federal, nos princípios da Universalidade e da Igualdade (Brasil, 1988), garantindo que qualquer pessoa terá direito às ações e serviços de saúde que necessitem, sem qualquer barreira, e sob as mesmas condições, sem qualquer discriminação ou preconceito (Paim, 2015).

A Constituição, para cumprimento dos princípios citados, define que o SUS será financiado pela União, estados, Distrito Federal e municípios, sem que haja necessidade de desembolso direto pelo usuário, garantindo a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, como regulamentado pela Lei nº 8.080/1990.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), para assegurar a Assistência Farmacêutica, o país deve garantir: acesso a medicamentos por parte de toda população, de acordo com os princípios de eqüidade e justiça social que devem caracterizar as políticas do setor saúde; a disponibilidade de medicamentos com qualidade, segurança e eficiência terapêutica; e o uso terapeuticamente racional e economicamente eficiente dos medicamentos por parte de profissionais de saúde e usuários (Organização Pan-Americana da Saúde, 2005).

Porém não é possível falar em acesso universal, justo, equânime e integral a medicamentos sem o adequado financiamento (Ferreira et al., 2024). Na mesma linha, em 2019, durante uma reunião de alto-nível das Nações Unidas sobre cobertura universal de saúde, foi aprovada a Resolução 74/2 que reafirma em seu item 9 que os sistemas universais de saúde devem garantir a todas as pessoas, sem qualquer discriminação, um conjunto de serviços de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, cura e reabilitação, incluindo o acesso aos medicamentos; ainda no item 45 da mesma resolução está destacada a necessidade de um financiamento suficiente, previsível e sustentável para que se possa oferecer cobertura universal aos serviços de saúde, sem criar barreiras ou dificuldades

financeiras para os usuários, em particular aqueles considerados pobres, vulneráveis ou marginalizados pela população (Naciones Unidas, 2019).

Como se pode depreender do texto da Resolução 74/2, o acesso ao medicamento, em países que adotam Sistemas Universais de Saúde, apresenta duas faces de uma mesma moeda: financiamento público e garantia de acesso. Quando analisamos o financiamento de medicamentos em países que adotam Sistemas Universais de Saúde, como: Brasil, Canadá, Reino Unido e Austrália, observa-se que todos convergem para o financiamento público, mas quando analisamos sob o prisma da garantia de acesso, percebe-se uma diversidade (Oliveira; Nascimento; Lima, 2020).

Os sistemas de saúde Inglês e Australiano possuem uma lista de medicamentos padronizados que são adquiridos, financiados e distribuídos pelo estado, mas o acesso gratuito está restrito a algumas situações específicas, como: internações; tratamentos de doenças como: tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis, transtorno mental; pacientes idosos; mulheres grávidas e com filhos até 1 ano de idade; estudantes até 18 anos; portadores de deficiência e pessoas de baixa renda. Para as demais pessoas o medicamento é fornecido pelo modelo de copagamento, no qual parte da despesa é custeada pelo estado e outra parte o usuário realiza desembolso direto. Segundo Oliveira *et al*, em 2019, os usuários do Reino Unido desembolsavam £8,40 (oito libras e quarenta centavos) por medicamento prescrito (Oliveira; Nascimento; Lima, 2020).

O Canadá também oferece um Sistema Universal de Saúde, dando autonomia para cada uma das 13 províncias ou territórios assumir leis de saúde específicas. Em relação aos medicamentos, é comum entre as províncias a gratuidade de hemoderivados, vacinas e medicamentos ministrados nos hospitais, para os demais medicamentos ambulatoriais há uma variedade de modelos adotados, que se baseiam em planos de seguros de medicamentos e, em regra, o acesso não é gratuito (Oliveira; Nascimento; Lima, 2020).

O Brasil, diferente dos demais países citados, garante o acesso aos medicamentos sem que haja necessidade de desembolso direto pelo usuário, tanto para os tratamentos na Atenção Primária à Saúde, associados ao CBAF, quanto

para os tratamentos vinculados aos Componentes Estratégico e Especializado da Assistência Farmacêutica. Além disso, garante vacinas, hemoderivados, tratamentos para o câncer, medicamentos utilizados durante hospitalizações e qualquer outra situação em que a pessoa estiver sob a tutela do Sistema Único de Saúde, sem qualquer critério relacionado à renda, idade, condição social, diagnóstico clínico entre outros (Brasil, 1990).

Numa análise mais ampliada, observa-se que o acesso aos medicamentos nos sistemas Inglês, Australiano e Canadense aproximam-se mais da lógica de um Sistema de Cobertura Universal de Saúde, caracterizado por: elenco reduzido de medicamentos e desembolso direto ou por contratação de seguros de saúde. Já o SUS oferece um modelo baseado no Sistema Universal de Saúde, que se contrapõe ao anterior pelo fato de garantir a todas as pessoas o acesso ao medicamento sem nenhuma barreira de acesso ou dificuldade financeira (Giovanella et al., 2018; Oliveira; Nascimento; Lima, 2020; Organização Mundial de Saúde, 2023).

3.2. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO BRASIL

Os primeiros passos da Assistência Farmacêutica como política de governo datam do início da década de 70, mais precisamente em 1971, com a criação e regulamentação da Central de Medicamentos (CEME), que tinha o propósito de “promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis, de medicamentos de uso humano àqueles que, por suas condições econômicas, não puderam adquiri-los por preços comuns no mercado” (Brasil, 1971).

Nesse período, as ações de saúde pública eram incipientes, o acesso ao tratamento estava mais voltado aos brasileiros vinculados ao mercado formal de trabalho, o estado não adotava a ideia de saúde como um direito social, e o atendimento gratuito, portanto, era restrito, sendo executado normalmente por instituições filantrópicas (Paim, 2015). A CEME nasce nesse contexto e, inicialmente, não adota a distribuição gratuita de medicamentos, porém isso muda em pouco tempo, e em 1972, o Decreto Presidencial nº 71.205/1972, no parágrafo único do artigo 1º, concede à CEME a possibilidade da distribuição gratuita de medicamentos (Brasil, 1972).

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por disputas sociais na área da saúde, com poucos avanços na oferta de medicamentos, mas no início da década de 90 a Assistência Farmacêutica é declarada como direito de todos com a publicação da Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, o qual fora previsto na Constituição Federal de 1988 como um sistema público, gratuito e que garante atendimento integral.

A CEME, que permaneceu ativa depois da publicação da Lei nº 8.080/1990, seguia com seu modelo centralizado de administração da Assistência Farmacêutica, que a esta altura revelava-se incompatível com os novos ares do SUS, e já apresentava sinais de desgastes, por exemplo: estoque irregular de medicamentos, com excesso de alguns medicamentos e falta de outros; desarticulação com a necessidade dos municípios; perda de medicamentos por vencimento; relação de medicamentos essenciais adotados pela CEME incompatível com a realidade dos municípios (Cosendey, 2000).

O final da década de 90 é marcado por duas ações importantes, a extinção da CEME, em 1997, e a publicação da Política Nacional de Medicamentos, em 1998. A partir de então o financiamento passa por etapas de qualificação com movimento progressivo e unidirecional no sentido de descentralização da gestão dos recursos, dando maior autonomia aos municípios, sem renunciar aos seguintes pilares: relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME) e financiamento tripartite, ou seja, com participação da União, dos estados e dos municípios.

Atualmente o custeio da Assistência Farmacêutica está regulamentado pela Portaria de Consolidação nº 06/2017, o qual é dividido em três componentes (Brasil, 2017a):

a) Componente Básico da Assistência Farmacêutica - destinado a aquisição de medicamentos e insumos relacionados a agravos e programas específicos no âmbito da Atenção Primária à Saúde;

b) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - destinado ao financiamento da assistência farmacêutica dos seguintes programas estratégicos: controle de endemias, tais como a tuberculose, a

hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; anti-retrovirais do programa DST/aids; sangue e hemoderivados; imunobiológicos; e medicamentos do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais.

c) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - promove o acesso a medicamentos, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

A partir dessa estrutura, alicerçadas nos pilares da municipalização da gestão da Assistência Farmacêutica e da relação de medicamentos essenciais definidas pelos municípios, o Brasil, como nação, consolida a proposta de oferecer, para todas as pessoas, como parte de um Sistema Universal de Saúde, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

3.3. FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Para garantir o acesso gratuito ao medicamento, o SUS adotou estratégias de financiamento diferenciadas para cada um dos Componentes da Assistência Farmacêutica. O financiamento dos Componentes Estratégico fica sob a responsabilidade da União. (Brasil, 2017a)

O financiamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica possui uma dinâmica própria e está atrelado ao grupo que o medicamento pertence:

Grupo 1: o financiamento fica sob a responsabilidade da União.

Grupo 2: o financiamento fica sob a responsabilidade das secretarias estaduais de saúde e do Distrito Federal. Este grupo é composto por medicamentos de menor complexidade, quando comparado ao Grupo 1, e que são uma opção para pacientes refratários ou que apresentaram intolerância à primeira linha de tratamento.

Grupo 3: o financiamento é tripartite, pois este grupo é composto por medicamentos constantes do CBAF e que também são indicados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. (Brasil, 2017b)

Sobre o CBAF, o financiamento é tripartite e, atualmente, está definido da seguinte maneira:

União: os valores a serem repassados para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos do CBAF serão definidos com base no contingente populacional e no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM):

a) IDHM muito baixo: R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos) por habitante/ano;

b) IDHM baixo: R$7,80 (sete reais e oitenta centavos) por habitante/ano;

c) IDHM médio: R$7,55 (sete reais e cinquenta e cinco centavos) por habitante/ano;

d) IDHM alto: R$7,30 (sete reais e trinta centavos) por habitante/ano;

e) IDHM muito alto: R$7,20 (sete reais e vinte centavos) por habitante/ano; e

Estados: R$3,01 (três reais e um centavo) por habitante/ano; e

Municípios: R$3,01 (três reais e um centavo) por habitante/ano (Brasil, 2017a, 2024).

A discussão sobre o financiamento e o modelo de acesso ao medicamento é sempre um ponto preocupante, especialmente no Brasil, que se comprometeu a garantir a Assistência Farmacêutica como direito de todos e dever do Estado, pois a Assistência Farmacêutica tem o medicamento como seu principal instrumento para prevenção de agravos, promoção da saúde e tratamento das doenças (Emmerick, 2006).

3.4. MODALIDADES DE COMPRA NO SETOR PÚBLICO

O processo de compra do setor público ocupa uma posição estratégica na aquisição de medicamentos e está submetido a requisitos legais, normativos, administrativos e jurídicos, com o objetivo de assegurar a contratação mais vantajosa para a Administração Pública (Brasil, 2021; Silva, 2022).

Para isso, é necessário que o município leve em consideração os princípios elencados na Lei de Licitações e Contratos Administrativos: legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável (Brasil, 2021).

Portanto, a escolha da proposta mais vantajosa aplicada à compra de medicamentos, à luz dos princípios acima descritos, vai além da análise do preço, deve contemplar a qualidade do bem adquirido, a celeridade no processo de aquisição e no recebimento do bem pretendido (Brasil, 2021; Silva, 2022).

Para alcançar os objetivos esperados, a legislação estratifica os bens e serviços a serem adquiridos sob alguns critérios, por exemplo: valor, especificidade, complexidade, disponibilidade no mercado; e define como modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo; que possuem ritos processuais específicos de acordo com a classificação do objeto a ser contratado (Brasil, 2021).

Os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica são classificados como bens e serviços comuns: “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”; e define o pregão como a modalidade de licitação obrigatória para aquisição desses bens (Brasil, 2021).

Esta modalidade é composta de sete etapas sequenciais, referenciadas abaixo, cada uma delas com exigências específicas, como: prazos, divulgação, formalização, registros, critérios de julgamento; que requer do ente licitante pessoal qualificado e estrutura administrativa compatível com a complexidade e burocracia exigida (Brasil, 2021):

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

Definir o pregão como modalidade de licitação obrigatória para compra de medicamentos não significa dizer que esse seja o único caminho disponível para o município adquirir os itens do CBAF. O estado da Bahia, por exemplo, oferece aos municípios a possibilidade de aderir ao Modelo de Registro de Preço Compartilhado (Bahia, 2022b).

Nessa modalidade, o estado informa aos municípios que realizará o registro de preço de um ou mais medicamentos do CBAF, os municípios formalizam o interesse nos itens licitados e o estado realiza o pregão. Sendo assim, os municípios que aderem a essa modalidade não precisam arcar com o ônus técnico e administrativo para realizar o pregão (Bahia, 2022b; Brasil, 2021).

Cada município deve avaliar o que é mais vantajoso: realizar o pregão ou aderir ao Modelo de Registro de Preço Compartilhado, levando em consideração capacidade técnica, estrutura administrativa, custo operacional e histórico das licitações realizadas pelo município.

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

4.1. TIPO DE ESTUDO

Para analisar o modelo de financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica adotado pelo estado da Bahia, foi realizado um estudo descritivo transversal, utilizando os dados disponíveis no Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF) e no Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços (SIMPAS) referentes aos anos de 2022 e 2023.

4.2. FONTE E COLETA DE DADOS

No SIGAF foram extraídos os dados referentes à movimentação dos medicamentos e volume de recursos financeiros utilizados, considerando as compras realizadas pelos municípios e os medicamentos transferidos pelo estado para os municípios. Nesse sistema foram acessadas informações, como: macrorregião de saúde, data, nome do medicamento, valor unitário, quantidade comprada e fonte do financiamento, se federal, estadual ou municipal. Quanto às fontes de financiamento, a fonte estadual refere-se à modalidade na qual o medicamento é transferido do estado para o município em atendimento à contrapartida estadual do CBAF; as fontes municipal ou federal referem-se à modalidade em que a compra é efetuada a partir de um processo licitatório conduzido pelo próprio município. Para este trabalho foram analisados todos os registros do SIGAF nos anos de 2022 e 2023.

No SIMPAS foram acessados os dados das compras efetuadas pelos municípios por meio do Registro de Preços Compartilhado dos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (BAHIA, 2020b) nos anos de 2022 e 2023.

Assim como no SIGAF, o SIMPAS também fornece as informações necessárias para isolar as variáveis e calcular os indicadores, que permitirão fazer as análises comparativas, como: macrorregião de saúde, data, nome do medicamento, valor unitário, quantidade comprada e fonte do financiamento, se federal ou municipal. O que muda é a modalidade de compra, o SIGAF demonstra

os dados das licitações feitas diretamente pelo município ou dos medicamentos transferidos pelo estado e o SIMPAS possui os dados das compras realizadas por meio do Registro de Preço Compartilhado.

4.3. VARIÁVEIS UTILIZADAS

Para alcançar os objetivos propostos foram utilizadas as variáveis abaixo:

d) macrorregião de saúde;

e) nome do medicamento;

f) valor unitário do medicamento;

g) quantidade do medicamento adquirido pela macrorregião de saúde;

h) quantidade do medicamento fornecido pelo estado;

i) modalidade de aquisição: licitação realizada pelo município, medicamentos transferidos pelo estado ou Registro de Preço Compartilhado.

Ao isolar essas variáveis e calcular os indicadores descritos abaixo, foi possível identificar em qual modalidade os medicamentos são comprados pelo menor custo.

Além das variáveis diretamente relacionadas com a compra, descritas acima, os dados também foram analisados com base na *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC) (WHO, 2024), um sistema de classificação de fármacos desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, que tem como uma das suas finalidades fazer uma padronização mundial dos medicamentos. A ATC possui 05 níveis diferentes de classificação, no presente estudo foi utilizado o nível 1, que corresponde ao grupo anatômico ou farmacológico associado ao medicamento e é representado por uma letra, por exemplo: A (Trato digestivo e metabolismo).

4.4. TRATAMENTO DOS DADOS

Foram disponibilizados os dados brutos do SIGAF e do SIMPAS, em arquivos separados para cada uma das modalidades de compra: município, Registro de Preço Compartilhado e transferência do estado para os municípios, constando todos os registros de movimentação de medicamentos dos anos de 2022 e 2023, separados por macrorregião de saúde. Por questões internas e de segurança dos dados, a Superintendência da Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde não disponibilizou o nome dos municípios, o que justificou a análise segundo agregados espaciais por macrorregião de saúde do estado da Bahia.

Para viabilizar as análises pretendidas, foram necessárias algumas etapas de tratamento dos dados:

a) a primeira ação foi excluir as Especialidades Farmacêuticas que não compõem a lista de medicamentos passíveis de serem adquiridos com recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que estão elencados na Resolução CIB nº 49/2015; (Bahia, 2015b)
b) a segunda ação foi padronizar a nomenclatura das Especialidades Farmacêuticas, pois o mesmo item estava descrito de diversas maneiras em cada um dos arquivos disponibilizados, utilizando como referência a nomenclatura constante na Resolução CIB nº 49/2015, por exemplo: o Ácido fólico 0,2mg/mL - solução oral - 30 ml foi encontrado com as seguintes descrições: ACIDO FOLICO, 0,2 MG/ML, SOL. ORAL, FRASCO COM 30ML, ÁCIDO, FÓLICO, 0,2 MG/ML, GOTAS 30ML e ACIDO, folico, 0,2 mg/ml, sol. oral, frasco com 30ml;
c) a terceira ação consistiu em identificar a modalidade de aquisição do medicamento: processo licitatório conduzido pelo município, Registro de Preço Compartilhado ou medicamento transferido pelo estado para o município;
d) a quarta ação serviu para identificar quais medicamentos constavam simultaneamente nas listas das três modalidades descritas no item anterior;

e) a quinta ação permitiu que fossem retirados todos os medicamentos que não atendiam ao requisito de constarem simultaneamente nas três modalidades de aquisição em análise.

Ao final do tratamento foram identificadas 55 especialidades farmacêuticas que atendiam aos critérios de análise, totalizando 97.673 registros individuais nos anos de 2022 e 2023, em cada registro individual constam: macrorregião de saúde, modalidade de aquisição, nome do medicamento, preço unitário, quantidade adquirida e valor total.

4.5. INDICADORES UTILIZADOS

Para viabilizar a análise e comparar as modalidades possíveis de aquisição de medicamentos: pelo município, distribuição direta pelo estado ou Registro de Preço Compartilhado, foram definidos os seguintes indicadores:

a) indicador 1 - demonstra o custo médio da Especialidade Farmacêutica (EF) em cada uma das modalidades de aquisição, considerando todas as compras no estado da Bahia, tendo como numerador a soma do total dos custos com a EF e como denominador a soma da quantidade adquirida da respectiva EF em cada uma das modalidades:

$$\text{Custo médio da EF no estado} = \frac{\text{Valor total gasto com a EF no estado}}{\text{Qdade de unidades adquiridas da EF no estado}}$$

b) indicador 2 - demonstra custo médio da Especialidade Farmacêutica por macrorregião de saúde e por modalidade de compra, tendo como numerador a soma do total custos com a EF e como denominador a soma da quantidade adquirida da respectiva EF em cada uma das modalidades, ambos relacionados com a respectiva macrorregião de saúde:

$$\text{Custo médio da EF na macrorregião de saúde} = \frac{\text{Valor total gasto com a EF na macrorregião de saúde}}{\text{Qdade de unidades adquiridas da EF na macrorregião de saúde}}$$

Para ilustrar o cálculo dos indicadores, segue um exemplo fictício: foi analisado o medicamento, Ácido fólico 0,2mg/mL - solução oral - 30 m, nas 03 modalidades de compras: medicamento transferido pelo estado, licitação municipal e Registro de Preço Compartilhado; para facilitar o cálculo, foi considerado que todos compraram a mesma quantidade, 100.000 (cem mil) unidades, porém o estado gastou R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), o município R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) e o Registro de Preço Compartilhado R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)

Tabela 01 – Simulação do cálculo de Preço Médio dos medicamentos no estado da Bahia/macrorregião, segundo modalidade de compra nos anos de 2022 e 2023

Medicamento: Ácido fólico 0,2mg/mL - solução oral - 30 ml

	Valor total	**Quantidade total**	**Cálculo**	**Preço Médio**
Transferido pelo estado	R$470.000,00	100.000	$\frac{470.000}{100.000}$	R$4,70
Licitação Municipal	R$490.000,00	100.000	$\frac{490.000}{100.000}$	R$4,90
Registro de Preço Compartilhado	R$450.000,00	100.000	$\frac{450.000}{100.000}$	R$4,50

Fonte: exemplo fictício.

4.6. ANÁLISE DOS DADOS

Na primeira análise, os medicamentos foram agrupados de acordo com a sua nomenclatura, em seguida ordenados de acordo com a modalidade de aquisição e, ao final, foi somada a coluna valor total e a coluna quantidade total, para cada modalidade, com a finalidade de definir o valor médio de aquisição de cada medicamento.

Há, pelo menos, duas possibilidades para definir o valor médio da Especialidade Farmacêutica, calculando a média aritmética ou a média ponderada dos preços unitários. Optou-se pela média ponderada, pois esse método leva em consideração o preço unitário, a quantidade comprada e o valor total, dando maior segurança à análise, uma vez que a relevância de cada registro de compra, para a

composição do preço médio, aumenta à medida que aumenta a quantidade comprada (Tabela 01).

Sendo assim, o preço médio da Especialidade Farmacêutica foi definido pela divisão da soma da coluna do valor total (preço unitário multiplicado pela quantidade), de cada uma das modalidades, pela respectiva soma da coluna de quantidade total (Indicador 1).

Considerando a extensão territorial do estado da Bahia, foram avaliados o preço médio de 5 Especialidades Farmacêuticas em cada uma das 9 macrorregiões de saúde.

Para isso, foi utilizado o critério de maior volume de compra para selecionar os medicamentos a serem analisados. As Especialidades Farmacêuticas foram agregadas por macrorregião de saúde, em seguida foi realizada a soma da coluna quantidade de cada item e selecionou-se os 5 medicamentos de maior volume.

Após a seleção das Especialidades Farmacêuticas, foi realizado o cálculo da média ponderada de cada um dos medicamentos nas respectivas modalidades de aquisição (Indicador 2).

Ao final das análises será possível indicar a modalidade de aquisição mais vantajosa em cada um dos cenários descritos, estado e macrorregião de saúde, considerando como vantagem a modalidade que apresentar o menor preço médio por Especialidade Farmacêutica.

Os dados foram tratados e analisados utilizando-se o software Microsoft Excel.

5. ASPECTOS ÉTICOS

O acesso aos dados de compras e distribuição de medicamentos foi concedido mediante Termo de Anuência Institucional, datado de 14 de junho de 2024 e assinado pelo Superintendente da Superintendência da Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde; atendendo ao disposto nas Portarias nº 104/2021 e 687/2023 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

Quanto ao Comitê de Ética em Pesquisa, o atual estudo está dispensado de ser avaliado, considerando que utilizará dados secundários, de domínio público, sem informações de caráter individual ou por município, o que não enseja danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano. Atendendo, assim, à Resolução CNS nº 674, de 6 de maio de 2022.

6. RESULTADOS

Após o tratamento do banco de dados, foram analisados os registros de movimentação das 55 especialidades farmacêuticas que atenderam simultaneamente aos requisitos de estarem nos registros de compra direta do município, de compra pelo Registro de Preço Compartilhado, de transferência pelo estado e constarem no elenco do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

As análises foram feitas em duas perspectivas, primeiro foram feitas as análises com os dados consolidados em nível estadual, em seguida os dados foram agrupados e analisados por macrorregião de saúde do estado da Bahia, porque a extensão territorial e a desigual distribuição geográfica dos municípios entre as regiões da Bahia podem interferir no preço de compra do medicamento.

6.1. DADOS CONSOLIDADOS EM NÍVEL ESTADUAL

A primeira análise consistiu em comparar as **3 modalidades de aquisição estudadas**, distribuindo os 97.673 registros de compra das especialidades farmacêuticas nos anos de 2022 e 2023, a qual demonstrou que não houve uma variação significativa das modalidades entre os anos. Contudo, observa-se uma diminuição da participação do estado na transferência de medicamentos, que passou de 72% do total de registros analisados em 2022 para 64% em 2023; e um aumento da participação do Registro de Preço Compartilhado, passando de 17% em 2022 para 23% em 2023 dos registros de compras em cada um dos anos (Tabela 02).

Tabela 02 – Participação percentual no quantitativo de registros de compras de medicamentos, distribuídos pelas 3 modalidades de aquisição - Anos 2022 e 2023

Modalidade	2022	2023
Transferência do estado	72%	64%
Compra direto pelo município	11%	14%
Registro de Preço Compartilhado	17%	22%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF.

Em seguida, este trabalho buscou analisar a distribuição do **volume de medicamentos adquiridos (estado, município e RPC)**, comparando a quantidade comprada em cada uma das 3 modalidades com a quantidade total de medicamentos adquiridos em 2022 e 2023, observou-se que o estado foi responsável por 49% dos itens transacionados nos registros estudados (Tabela 03).

Tabela 03 – Participação percentual no quantitativo de itens adquiridos, distribuídos pelas 3 modalidades de aquisição - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Percentual
Transferência do estado	49%
Compra direto pelo município	21%
Registro de Preço Compartilhado	30%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF.

Além da análise sobre a quantidade de medicamentos comprados, foram calculados os **preços médios das 55 especialidades farmacêuticas (EF) em cada uma das 3 modalidades de aquisição estudadas**, nos anos de 2022 e 2023, para identificar os menores e os maiores preços médios, conforme tabela 04.

Tabela 04 – Preço médio (R$) das 55 especialidades farmacêuticas em cada uma das 3 modalidades de compra - Anos 2022 e 2023

Medicamento	Estado	Município	RPC	Economia
Ácido fólico 0,2mg/mL - solução oral - 30 ml	4,664	**4,120**	5,032	18%
Amitriptilina, cloridrato 25mg - comprimido	**0,057**	0,070	0,058	19%
Amoxicilina 500mg - cápsula ou comprimido	**0,157**	0,197	0,182	20%
Amoxicilina 500mg + Clavulanato de potássio 125mg - comprimido ou cápsula	1,257	**0,804**	1,375	42%
Amoxicilina 50mg/mL - pó para suspensão oral - 60 ml	**3,984**	4,947	5,686	30%
Amoxicilina 50mg/mL + Clavulanato de potássio 12,5mg/mL - suspensão oral - 75 ml	15,992	**11,258**	18,274	38%
Azitromicina 40mg/mL - pó para suspensão oral - 15 ml	5,848	**5,479**	5,674	6%
Azitromicina 500mg - comprimido revestido ou cápsula	0,934	0,971	**0,826**	15%
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI - pó para suspensão injetável	7,081	7,433	**6,948**	7%
Biperideno, cloridrato 2mg comprimido	0,210	0,231	**0,205**	11%
Carbamazepina 200mg - comprimido	0,163	0,174	**0,157**	10%

Medicamento	Estado	Município	RPC	Economia
Carbamazepina 20mg/mL - suspensão oral - frasco com 100mL	**8,144**	8,397	8,372	3%
Carbonato de cálcio 500mg + Colecalciferol 400 UI - comprimido	**0,080**	0,118	0,127	37%
Carbonato de lítio 300mg - comprimido	0,303	**0,231**	0,301	24%
Cefalexina 500mg- comprimido	0,629	0,493	**0,435**	31%
Clomipramina, cloridrato 25mg - comprimido	0,650	**0,650**	0,663	2%
Clorpromazina, cloridrato 100mg - comprimido	**0,231**	0,249	0,245	7%
Dexclorfeniramina, maleato 0,4mg/mL - solução oral - frasco 100 - 120 ml	**1,172**	1,903	2,022	42%
Diazepam 10 mg - comprimido	**0,062**	0,075	0,064	18%
Diazepam 5mg - comprimido	**0,051**	0,064	0,058	20%
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,052**	0,066	0,063	22%
Fenitoína sódica 100mg - comprimido	**0,107**	0,110	0,113	5%
Fenobarbital 100mg - comprimido	**0,121**	0,165	0,170	29%
Fenobarbital sódico 40mg/mL - solução oral - frasco 20ml	**3,468**	4,333	4,234	20%
Fluoxetina, cloridrato 20mg - comprimido ou cápsula	**0,066**	0,071	0,067	8%
Furosemida 40mg - comprimido	**0,053**	0,061	0,055	13%
Glibenclamida 5mg - comprimido	**0,026**	0,030	0,028	12%
Gliclazida 30mg - comprimido de liberação controlada	0,121	0,110	**0,101**	17%
Haloperidol 1mg - comprimido	**0,136**	0,148	0,146	8%
Haloperidol 2mg/mL - solução oral - frasco 20 - 30 ml	**2,581**	2,972	3,071	16%
Haloperidol 5mg - comprimido	0,218	**0,176**	0,198	19%
Haloperidol, decanoato 50mg/mL - solução injetável - ampola 1ml	**4,242**	5,845	5,918	28%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,028	0,026	13%
Ibuprofeno 50mg/mL - solução oral - frasco 30 ml	**1,292**	1,662	1,771	27%
Ibuprofeno 600 mg - comprimido	0,176	0,165	**0,151**	14%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,068	0,065	**0,058**	15%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,078**	0,098	0,096	21%
Metildopa 250mg - comprimido	**0,348**	0,517	0,409	33%
Metronidazol 100mg/g - gel vaginal - tubo 50 g + 10 aplicadores	**4,707**	5,361	5,150	12%
Metronidazol 250mg - comprimido	0,125	0,138	**0,120**	13%

Medicamento	Estado	Município	RPC	Economia
Metronidazol, benzoil 40mg/mL - suspensão oral - frasco 100 ml	**5,585**	7,788	6,832	28%
Miconazol, nitrato 2% - creme vaginal - tubo 80g + 14 aplicadores	5,592	**2,521**	5,469	5%
Omeprazol 20mg - cápsula	**0,084**	0,103	0,098	18%
Paracetamol 200mg/mL - solução oral - frasco 15 ml	**1,014**	1,346	1,305	25%
Paracetamol 500mg - comprimido	**0,082**	0,102	0,102	19%
Prednisona 20mg - comprimido	0,157	**0,154**	0,155	2%
Prometazina 25mg - comprimido	0,106	**0,134**	0,136	22%
Sais para reidratação oral - sachê com 27,9g	**0,941**	0,960	1,013	7%
Salbutamol, sulfato 100mcg/dose - aerossol oral - 200 doses	**7,477**	8,181	7,797	9%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,067**	0,077	0,075	13%
Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg - comprimido	**0,149**	0,192	0,184	23%
Sulfametoxazol 40mg/mL + Trimetoprima 8mg/mL - suspensão oral - frasco 100 ml	5,763	4,243	**4,109**	29%
Sulfato ferroso 40 mg Fe2+ - comprimido	0,036	**0,015**	0,035	11%
Valproato de sódio 57,624mg/mL (equivalentea 50mg de ácido valpróico/mL) - xarope - 100 ml	3,603	**3,591**	4,044	11%
Valproato de sódio 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico) - comprimido	**0,411**	0,547	0,449	25%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Analisando, ainda, os preços médios dos medicamentos, foram identificados os menores e os maiores preços médios para cada uma das 55 especialidades farmacêuticas estudadas, e classificados conforme as modalidades de aquisição.

A tabela 05 mostra que entre as 55 especialidades farmacêuticas que tiveram **menor preço médio**, 34 EF foram adquiridas via transferência do estado, ou seja, foram comprados e repassados ao município. Por sua vez, quando observado o contrário, o **maior preço médio** concentrou-se nas compras realizadas diretamente pelo município (30 EF), seguida de 16 itens das compras municipais realizadas pelo registro de preço compartilhado (Tabela 05).

Tabela 05 – Modalidade de compra, menor e maior preço médio do conjunto de especialidades farmacêuticas - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Nº de EF (menor preço médio)	Nº de EF (maior preço médio)
Transferência do estado	34	09
Compra direto pelo município	09	30
Registro de Preço Compartilhado	12	16

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Considerando que a partir de 2025 todos os municípios receberão o valor estadual do Componente Básico, restarão duas opções disponíveis: a compra direta pelo município ou o Registro de Preço Compartilhado. Sendo assim, foram analisados os preços médios dos medicamentos, excluindo os preços praticados pelo estado, observou-se o menor preço médio de compra em 35 EF adquiridas pelo Registro de Preço Compartilhado (Tabela 06).

Tabela 06 – Número de especialidades farmacêuticas com menor e maior preços médio nas modalidades: compra direta e Registro de Preço Compartilhado - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Menor preço médio	Maior preço médio
Compra direto pelo município	20	35
Registro de Preço Compartilhado	35	20

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Além da análise direta sobre as quantidades adquiridas e os preços médios, as **55 especialidades farmacêuticas** foram estudadas a partir da *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC) (WHO, 2024).

A primeira análise teve como objetivo classificar as especialidades farmacêuticas de acordo com o grupo principal da ATC, observa-se que o principal grupo foi o N - Sistema Nervoso, seguido pelo grupo J - Anti-Infecciosos Para Uso Sistêmico, representando 36,4% e 21,8% respectivamente (Tabela 07).

Tabela 07 – Distribuição das 55 especialidades farmacêuticas entre os grupos anatômicos ou farmacológicos, de acordo com a ATC.

Grupo Anatômico ou Farmacológico	Quantidade	Percentual
A -Trato Digestivo e do Metabolismo	6	10,9%
B -Sangue e Órgãos Hematopoiéticos	2	3,6%
C - Aparelho Cardiovascular	6	10,9%
G - Sistema Geniturinário e Hormônios Sexuais	2	3,6%
H - Medicamentos Hormonais Sistêmicos, Exceto Hormônios Sexuais e Insulinas.	1	1,8%
J - Anti-Infecciosos Para Uso Sistêmico	12	21,8%
M - Aparelho Músculo-Esquelético	2	3,6%
N - Sistema Nervoso	20	36,4%
P - Produtos Antiparasitários, Inseticidas e Repelentes.	1	1,8%
R - Sistema Respiratório	3	5,5%
TOTAL	55	100%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF.

Na segunda perspectiva, a análise baseou-se no quantitativo de itens adquiridos e, para isso, foram identificados os 10 medicamentos comprados em maior quantidade. Observou-se que a Losartana potássica 50mg - comprimido representou 19% do total de unidades adquiridas nos anos de 2022 e 2023, sendo seguida por Hidroclorotiazida 25mg - comprimido e Metformina, cloridrato 850mg comprimido que representaram 12% e 11% respectivamente (Tabela 08). Em seguida, os medicamentos foram classificados de acordo com a ATC e foi possível observar que 4 dos 5 medicamentos que foram comprados em maior quantidade compõem o grupo C - Aparelho Cardiovascular.

Tabela 08 – Percentual das 10 especialidades farmacêuticas adquiridas em maior quantidade e respectiva classificação ATC - Anos 2022 e 2023.

Medicamento	Percentual	ATC
Losartana potássica 50mg - comprimido	19%	C
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	12%	C
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	11%	A
Sinvastatina 20mg - comprimido	6%	C
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	5%	C
Glibenclamida 5mg - comprimido	4%	A
Fluoxetina, cloridrato 20mg - comprimido ou cápsula	4%	N
Sulfato ferroso 40 mg Fe2+ - comprimido	3%	B
Carbamazepina 200mg - comprimido	3%	N
Amitriptilina, cloridrato 25mg - comprimido	3%	N

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF.

Para concluir, foi feita uma análise da classificação ATC a partir do ponto de **vista financeiro**. Para isso, foram somados os valores totais investidos nas 3 modalidades de aquisição, nos anos de 2022 e 2023, em seguida foram identificados os 10 medicamentos que tiveram maior representatividade financeira.

Observou-se que a Losartana potássica 50mg - comprimido consumiu 10% do valor investido nas 55 especialidades farmacêuticas (R$138.620.790,41), seguida da Metformina, cloridrato 850mg comprimido e Valproato de sódio 576mg - comprimido, que consumiram 8% e 7% respectivamente do valor total. Ao classificar os medicamentos com base no grupo principal da ATC, observa-se que há 6 medicamentos dos grupos A - Trato Digestivo e do Metabolismo e C - Aparelho Cardiovascular, representando juntos 30% do valor total estudado (Tabela 09).

Tabela 09 – Percentual das 10 especialidades farmacêuticas com maior montante financeiro e respectiva classificação ATC - Anos 2022 e 2023.

Medicamento	Percentual	ATC
Losartana potássica 50mg - comprimido	10%	C
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	8%	A
Valproato de sódio 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico) - comprimido	7%	N
Carbamazepina 200mg - comprimido	5%	N
Sinvastatina 20mg - comprimido	4%	C
Gliclazida 30mg - comprimido de liberação controlada	3%	A
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	3%	C
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	3%	C
Ibuprofeno 600 mg - comprimido	3%	M
Cefalexina 500mg- comprimido	2%	J

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF.

6.2. DADOS CONSOLIDADOS POR MACRORREGIÃO DE SAÚDE

Após apresentar os dados para todo o estado da Bahia, seguem os resultados segundo as 9 macrorregiões de saúde: centro leste, centro norte, extremo sul, leste, nordeste, norte, oeste, sudoeste e sul (SESAB, 2007).

Para análise dos dados por macrorregião, foram descartados 878 registros de compra, porque não constava a variável macrorregião nesses registros, as análises, portanto, foram feitas sobre 96.795 registros de compras.

A primeira análise consiste em distribuir os registros de compras entre as macrorregiões de saúde. Observa-se que a macrorregião sudoeste foi responsável por 19% dos registros estudados, seguida das macrorregiões centro leste e sul com 16% e 15% respectivamente (Tabela 10).

Tabela 10 – Participação das macrorregiões nos registros de compra - Anos 2022 e 2023

Macrorregião	Percentual
Centro Leste	16%
Centro Norte	10%
Extremo Sul	4%
Leste	14%
Nordeste	8%
Norte	6%
Oeste	8%
Sudoeste	19%
Sul	15%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

O preço médio das especialidades farmacêuticas por macrorregião foi calculado levando em conta os preços praticados na compra direta pelo município e na compra pelo Registro de Preço Compartilhado, porque essas duas modalidades ficam sob a escolha e gestão do município. Por sua vez, os preços dos medicamentos da modalidade de aquisição: transferência pelo estado, não variam conforme a macrorregião de saúde, porque são sempre comprados pelo estado.

Dessa forma, observou-se que que o preço médio de aquisição se mostrou mais vantajoso em 10 especialidades farmacêuticas compradas pela macrorregião oeste, seguida das macrorregiões leste e norte com 8 especialidades farmacêuticas cada uma (Tabela 11).

Considerando as compras menos vantajosas, observou-se que o preço médio de aquisição se mostrou menos vantajoso em 15 especialidades farmacêuticas da macrorregião extremo sul, seguida das macrorregiões norte e leste com 10 e 09 especialidades farmacêuticas respectivamente (Tabela 11).

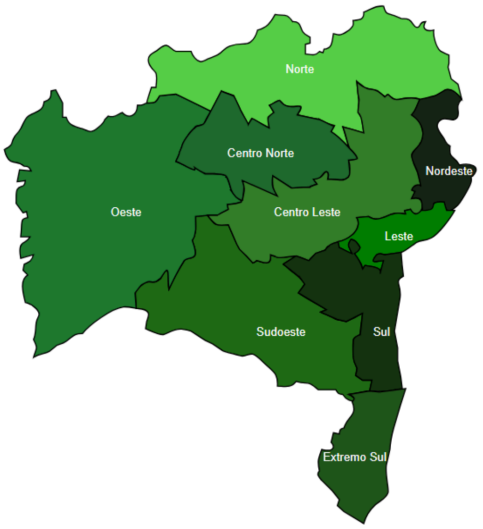
Tabela 11 – Número de especialidades farmacêuticas com menor e maior preços médios em cada uma das macrorregiões de saúde, modalidades: compra direta pelo município e RPC - Anos 2022 e 2023

Macrorregião	Menor preço médio	Maior preço médio
Centro Leste	2	5
Centro Norte	5	4
Extremo Sul	7	15
Leste	8	9
Nordeste	7	3
Norte	8	10
Oeste	10	2
Sudoeste	7	3
Sul	1	4
TOTAL	55	55

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Ao analisar os dados, observou-se que as macrorregiões mais distantes, oeste, norte e extremo sul, estão entre as que obtiveram os melhores resultados na análise de número de especialidades farmacêuticas com menor preço médio de compra (Tabela 11). A Figura 1 mostra a distribuição do estado da Bahia de acordo com suas macrorregiões de saúde.

Figura 1: Mapa do Plano Diretor de Regionalização do estado da Bahia - 2007



Fonte: Observatório Baiano de Regionalização
(https://obr.saude.ba.gov.br/pri/desenhoTerritorial/macros)

Foram selecionadas as 5 especialidades farmacêuticas com maior volume de compra nas 9 macrorregiões e comparado o preço médio em cada uma das 3 modalidades de compra estudadas. Observou-se que as especialidades farmacêuticas: Hidroclorotiazida 25mg - comprimido, Losartana potássica 50mg - comprimido e Metformina, cloridrato 850mg comprimido - apareceram em todas as macrorregiões. (Tabelas 12 a 20)

Tabela 12 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Centro Leste - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,053**	0,070	0,060	25%
Glibenclamida 5mg - comprimido	**0,026**	0,030	0,028	13%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,030	0,027	19%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,068	0,072	**0,058**	20%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,079**	0,105	0,098	25%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 13 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Centro Norte - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,053**	0,063	0,062	16%
Glibenclamida 5mg - comprimido	**0,026**	0,028	0,028	6%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,027	0,026	11%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,067	0,059	**0,056**	16%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,080**	0,104	0,108	26%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 14 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Extremo Sul - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Glibenclamida 5mg - comprimido	**0,026**	0,037	0,029	30%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,028	0,025	14%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,065	0,067	**0,057**	14%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,080**	0,083	0,127	37%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,068**	0,076	0,075	11%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 15 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Leste - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Fluoxetina, cloridrato 20mg - comprimido ou cápsula	**0,066**	0,068	0,067	3%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,026	0,026	9%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,071	0,063	**0,059**	18%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,076**	0,106	0,091	28%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,068**	0,076	0,075	10%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 16 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Nordeste - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,051**	0,066	0,057	23%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,027	0,026	11%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,065	0,066	**0,058**	12%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,078**	0,096	0,101	23%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,067**	0,075	0,075	11%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 17 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Norte - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,051**	0,059	0,063	19%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,029	0,026	18%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,063	0,063	**0,056**	11%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,076**	0,093	0,090	18%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,067**	0,073	0,075	11%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 18 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Oeste - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,052**	0,063	0,061	17%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,027	0,027	12%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,067	0,059	**0,055**	17%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,078**	0,103	0,101	25%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,068**	0,077	0,075	12%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 19 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Sudoeste - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Enalapril, maleato 20mg - comprimido	**0,052**	0,067	0,064	22%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,028	0,027	12%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,069	0,065	**0,057**	16%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,080**	0,088	0,089	10%
Sinvastatina 20mg - comprimido	**0,065**	0,081	0,075	19%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Tabela 20 – Preço médio (R$) das 5 especialidades farmacêuticas com maior quantidade (unidades) adquirida, segundo as 3 modalidades de compra, macrorregião Sul - Anos 2022 e 2023

Modalidade	Estado	Município - compra direta	Município - RPC	Economia
Glibenclamida 5mg - comprimido	**0,026**	0,030	0,028	13%
Gliclazida 30mg - comprimido de liberação controlada	0,119	0,115	**0,097**	19%
Hidroclorotiazida 25mg - comprimido	**0,024**	0,037	0,027	34%
Losartana potássica 50mg - comprimido	0,069	0,072	**0,058**	19%
Metformina, cloridrato 850mg comprimido	**0,078**	0,102	0,091	23%

Fonte: Dados extraídos dos sistemas SIMPAS e SIGAF

Analisando o preço médio das 3 EF que apareceram em todas as macrorregiões, verifica-se que o estado obteve o menor preço em todas as macrorregiões para a Hidroclorotiazida 25mg - comprimido e Metformina, cloridrato 850mg comprimido; e o RPC, também em todas as macrorregiões, obteve o menor preço para a Losartana potássica 50mg - comprimido.

Analisando a diferença entre os preços médios nas 3 modalidades de aquisição, constatou-se os maiores descontos na Metformina, cloridrato 850mg comprimido da macrorregião extremo sul e na Hidroclorotiazida 25mg - comprimido da macrorregião sul, com 37% e 34% respectivamente.

7. DISCUSSÃO

O processo de descentralização da gestão do SUS e a autonomia dos municípios configuram como princípios fundantes do modelo de saúde adotado pelo Brasil, a partir da Constituição de 1988, e a retrospectiva histórica do financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica demonstra que o estado da Bahia trilhou caminhos nessa direção. A descentralização, apesar de necessária, traz consigo desafios que pressionam o estado a buscar meios de controle que garantam a execução do financiamento do CBAF pelos municípios. (Pontes et al., 2017)

A análise dos dados reforça essa necessidade, pois sugerem sub-registro das compras efetuadas pelo município. Essa suposição se deu diante da observação que mais de 60% dos registros de compra analisados tinham como fonte a transferência de medicamentos do estado para os municípios (Tabela 02). Entretanto, esperava-se que houvesse uma participação maior dos municípios, considerando que este é responsável pela execução dos valores da União, que, em 2022 e 2023, variavam de R$5,85 a R$6,05 por habitante ano, e do município, R$2,36 por habitante ano, os quais, somados, representavam mais de três vezes o valor investido pelo estado — R$2,36 por habitante ano — no financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Bahia, 2022a).

Essa inversão sugere que o estado é mais regular na alimentação da movimentação dos medicamentos do CBAF e que há problemas, por parte dos municípios, na alimentação habitual do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF). Nesse contexto, a transferência da contrapartida estadual para os Fundos Municipais de Saúde (Bahia, 2024), sem controles mais efetivos para garantir que todos os municípios alimentem corretamente o SIGAF, pode fortalecer o subfinanciamento da Assistência Farmacêutica, como observaram Pontes *et al* (Pontes et al., 2017) e consequente desabastecimento de medicamentos nos municípios.

Sob o ponto de vista da administração municipal, especialmente os municípios que não possuem uma boa estrutura técnico-administrativa, conhecer a demanda de medicamentos e usar ferramentas administrativas pode aumentar a

capacidade de gestão dos itens do CBAF, qualificando o uso do recurso e o acesso ao medicamento.

Entre essas alternativas, pode-se sugerir o Princípio de Pareto, uma ferramenta de qualidade que pode ser utilizada para controle de estoque com a finalidade de indicar quais itens têm maior relevância; portanto, devem ser acompanhados mais de perto. Essa classificação, quando é feita de acordo com o volume de itens movimentados pelo almoxarifado, permite identificar que aproximadamente 80% da quantidade de itens distribuídos concentra-se em aproximadamente 20% dos itens disponíveis. A partir daí, estes são classificados em ordem de relevância, permitindo dar mais ênfase aos itens que têm maior movimentação, consequentemente diminuindo os riscos de desabastecimento e perda por validade (Daniel; Murback, 2014; Lima et al., 2020).

Neste estudo, observou-se a movimentação de 1.194.796.255 de unidades entre as 55 especialidades farmacêuticas estudadas. Ao classificar os medicamentos de acordo com a quantidade total de unidades distribuídas, observa-se que 71% de toda a movimentação está concentrada em 10 especialidades farmacêuticas (Tabela 08). A informação sugere, portanto, que ao concentrar esforços nos itens selecionados, o gestor diminuirá o risco de perda por validade, diminuirá o risco de falta de medicamento por desabastecimento e poderá dar mais atenção aos processos de compra desses medicamentos na busca de melhores preços e fornecedores.

Outro caminho possível para a gestão municipal, além do controle direto sobre a aquisição do medicamento, seria a análise reversa sobre a demanda, que pode auxiliar na identificação de doenças e agravos mais prevalentes na população. Ao classificar as especialidades farmacêuticas estudadas de acordo com a *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC), observa-se que 9 especialidades farmacêuticas, entre as 10 com maior volume de movimentação, ou seja, maior demanda, estão associadas aos grupos: A - Trato Digestivo e do Metabolismo (antidiabéticos), C - Aparelho Cardiovascular e N - Sistema Nervoso. Esse achado não é exclusivo do estado da Bahia, um estudo realizado com 960 municípios

brasileiros, entre julho de 2013 e junho de 2014, também chegou na mesma conclusão (Pontes et al., 2017).

Desse modo, o gestor municipal que está comprometido com o uso seguro e racional do medicamento, pode dar ênfase na construção de protocolos terapêuticos; capacitações para prescritores, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais de nível médio; além de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, relacionados com questões psicossociais, hipertensão e diabetes.

Para permitir um olhar ampliado sobre o medicamento, considerando as dimensões geográficas da Bahia e uma distribuição populacional dispersa em todo o território, os registros de compra de medicamentos foram agregados por macrorregião de saúde. (SESAB, 2007)

Havia expectativa que as macrorregiões mais distantes da capital operassem com preços médios mais altos, quando comparadas com as macrorregiões mais próximas da capital, por questões logísticas e dificuldade de acesso.

Entretanto ficou evidenciado que, apesar dos preços médios mais altos de compra para as macrorregiões mais distantes da capital (extremo sul e norte), também aparece a Leste, macrorregião em que a capital está situada. Ainda, a macrorregião oeste, uma das mais distantes da capital, é a que tem o menor número de especialidades farmacêuticas com preços médios mais altos de compra.

Portanto, diante da análise dos dados agregados por macrorregião de saúde, não foi possível afirmar que os preços dos medicamentos tendem a ficar mais altos à medida que o local de compra se distancia da capital do estado. Ou seja, esse conjunto de achados supõe a necessidade de investigações mais específicas e que incluam aspectos relacionados à logística na análise

Quanto ao achado que aponta que 62% dos itens com preços mais vantajosos concentram-se nos medicamentos transferidos pelo estado, pode ser explicado, entre outros motivos, pelo ganho de escala. Nesse processo, o preço do medicamento diminui à medida que aumenta a quantidade comprada, o que

favorece o estado, porque concentra os recursos e a demanda dos 417 municípios. A logística também se apresenta como uma vantagem, pois todas as compras realizadas pelo estado são entregues em um único local, diminuindo o custo de fornecimento. (Amaral; Blatt, 2011; CONASEMS, 2023)

A análise direta dessa situação conduz a pensar que os preços mais baixos de compras efetuadas pelo estado são uma vantagem aos municípios, e que a decisão do estado de transferir a contrapartida do CBAF para os FMS pode parecer desvantajosa. Entretanto, deve-se incluir nessa análise que a responsabilidade de retirar os medicamentos fica sob a gestão municipal, a qual deve disponibilizar um veículo para se deslocar a cada três meses até o centro de distribuição que fica em Salvador, capital do estado. Portanto, o gestor municipal precisa arcar com as despesas do transporte, que envolve o custo direto com o carro: depreciação, manutenção, impostos, seguros; o custo com o combustível e com os profissionais envolvidos no transporte. (CONASEMS, 2023; Dibai et al., 2023)

Por exemplo, desconsiderando os custos com o carro e com os profissionais, foi calculado o custo do combustível para um município com 15.740 habitantes, que fica a 864 quilômetros de distância de Salvador.

Para calcular o custo do combustível, foi utilizado como referência o veículo do modelo Fiorino, marca Fiat, categoria comercial, motor de propulsão a combustão, que utiliza álcool ou gasolina, que percorre 12,4 quilômetros com um litro de gasolina na estrada, com classificação “A” na comparação relativa na categoria, que está registrado no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro; e o preço médio da gasolina comum, R$5,83, em dezembro de 2023, no estado da Bahia, fornecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2024; INMETRO, 2024).

Considerando que foram percorridos 1.728 quilômetros, ida e volta do município até Salvador; que foram consumidos 139 litros de gasolina, dividindo a distância percorrida por 12,4, que representa o consumo de combustível do veículo; conclui-se que foram gastos R$810,37 (oitocentos e dez reais e trinta e sete centavos).

Tendo em vista que o estado deve fornecer R$37.146,40 (trinta e sete mil reais e quarenta centavos) por ano a um município com 15.740 habitantes e que as retiradas são trimestrais, cada viagem que o município faz para Salvador retira R$9.286,60 (nove mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) em medicamento.

Portanto, nesse cenário, observou-se que só o combustível representa um aumento de 9% no custo total do medicamento.

Além do mais, a transferência da contrapartida estadual do CBAF para os FMS fortalece a autonomia dos municípios, promove a descentralização da gestão do SUS e também beneficia a gestão estadual, pois não será mais necessário arcar com as despesas envolvidas no recebimento, armazenamento e separação dos medicamentos distribuídos para os municípios, como foi constatado na experiência de Minas Gerais (Dibai et al., 2023).

Cabe ressaltar o cenário previsto para 2025, quando será aplicada a decisão do estado da Bahia, a qual prevê que os municípios receberão a contrapartida estadual do CBAF diretamente no FMS, e haverá duas opções de compra disponíveis: a compra direta pelo município e o Registro de Preço Compartilhado. Nessa perspectiva, o estudo observou que o Registro de Preço Compartilhado demonstrou ser uma melhor opção para os municípios, considerando que na análise de comparação do preço médio, excluindo os preços praticados pelo estado, essa modalidade apresentou propostas de compras mais vantajosas em 35 itens, dos 55 estudados.

Além da vantagem objetiva, de que o Registro de Preço Compartilhado tende a oferecer preços mais vantajosos, ao aderir essa modalidade, o município simplifica todo o processo de compra de medicamentos, que requer o cumprimento de sete etapas técnico-administrativas, previstas na normativa legal, e seus desdobramentos. (CONASEMS, 2023)

Observa-se, portanto, que os preços praticados na compra direta pelo município mostraram-se desvantajosos nos três cenários analisados. No primeiro cenário, comparando as três modalidades de aquisição, a compra direta pelo

município teve os preços mais altos em 30 das 55 EF estudadas; no segundo cenário, comparando o RPC com a compra direta, 35 das 55 das EF estudadas tiveram os piores preços nas compras efetuadas pelo município; por último, analisando o preço médio das 3 EF que apareceram em todas as macrorregiões, em nenhuma das delas o município conseguiu o melhor preço.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão e compra de medicamentos é uma atividade complexa em si mesma, que envolve: perfil epidemiológico, controle de estoque, regras próprias de financiamento, condições especiais de armazenamento e ritos licitatórios minuciosos; exigindo dos gestores de saúde a formação de equipes qualificadas e ferramentas adequadas para dar suporte necessário aos profissionais envolvidos.

O presente estudo, que se propôs a analisar e comparar as 3 modalidades de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no estado da Bahia, pretende ser uma dessas ferramentas que auxiliam os gestores municipais a tomarem decisões baseadas em evidências.

Na gestão de compras e controle de estoque, o dirigente da saúde poderá identificar os medicamentos com maior relevância, tanto do volume de itens movimentados quanto do volume financeiro transacionado.

Como ficou demonstrado, as principais doenças e agravos relacionados com a demanda de medicamentos são referentes a questões psicossociais, doença hipertensiva e diabetes, servindo de balizador para ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos; e direcionador para priorizar a implantação de protocolos terapêuticos e a oferta de capacitação para os profissionais envolvidos na terapia farmacológica.

O uso de dados agregados não viabilizou a análise por municípios o que poderia identificar custo indireto com a retirada dos medicamentos, o impacto por oferecer um elenco reduzido de especialidades farmacêuticas e medicamentos solicitados pelo município que não são entregues pelo estado; essas questões precisam ser aprofundadas em estudos posteriores. Portanto, ainda que os melhores preços médios de compra de medicamentos tenham sido aqueles adquiridos pelo estado, os dados disponíveis não foram suficientes para atestar que essa é a melhor modalidade.

Quanto ao lançamento das compras de medicamentos nos sistemas oficiais, uma das formas de melhorar o controle é seguir estimulando o uso do Registro de

Preço Compartilhado. Além disso, essa modalidade se apresenta mais vantajosa para o município e para o estado. Do ponto de vista do município, nessa modalidade os preços dos medicamentos mostraram-se mais vantajosos e o processo de compra mais simplificado. Sob o ponto de vista do estado, o Registro de Preço Compartilhado mostrou-se mais vantajoso pois o município precisa inserir, obrigatoriamente, os dados no Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços (SIMPAS), permitindo que o estado faça o acompanhamento do uso dos recursos do CBAF.

Todavia, como já foi explicitado, a compra mais vantajosa para o município não se limita ao menor preço, sendo assim, serão necessários novos estudos que possam avaliar outras dimensões das compras pelo Registro de Preço Compartilhado, por exemplo, a capacidade das empresas entregarem os medicamentos nos preços pactuados, na quantidade solicitada e no prazo definido.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AMARAL, Silvâni Maria Sehnem do; BLATT, Carine Raquel. Consórcio intermunicipal para a aquisição de medicamentos: impacto no desabastecimento e no custo. **Revista de Saúde Pública**, v. 45, p. 799–801, ago. 2011.

2. ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. **Série histórica do levantamento de preços**. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-revenda-e-de-distribuicao-combustiveis/serie-historica-do-levantamento-de-precos>. Acesso em: 12 jun. 2024.

3. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 90/2011. **Aprova a adesão aos termos da Portaria GM/MS n° 4.217 de 28 de dezembro de 2010, define os valores e a forma de pactuação das contrapartidas do Estado e dos Municípios e aprova a forma de transferência do recurso federal**. 2 jun. 2011 a.

4. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 91/2011. **Aprova o elenco de referência de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica para a execução das contrapartidas federal, estadual e municipais, e define a forma de aplicação dos resursos estadual e municipais destinados aos insumos para Diabetes Mellitus de acordo com a Portaria GM/MS n° 4.217/10**. 2 jun. 2011 b.

5. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 12/2015. **Aprova a mudança da forma de repasse do recurso federal referente à contrapartida da Assistência Farmacêutica Básica de municípios do Estado da Bahia, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.**. 23 fev. 2015 a.

6. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 49/2015. **Aprova o elenco de referência de medicamentos e insumos do componente básico da Assistência Farmacêutica para execução das contrapartidas federal, estadual e municipais.**. 29 abr. 2015 b.

7. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 74/2015. **Aprova a mudança na forma de repasse do Recurso Federal referente à contrapartida da Assistência Farmacêutica Básica de municípios do Estado da Bahia, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.**. 29 jun. 2015 c.

8. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 152/2020. **Aprova as normas para execução do financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito do Estado da Bahia**. 11 set. 2020 a.

9. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 153/2020. **Aprova o Modelo de Registro de Preços Compartilhado dos**

medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, a ser realizado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e utilizado pelos Municípios do Estado.. 11 set. 2020 b.

10. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 215/2022. **Aprova as normas para execução do financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito do Estado da Bahia**. 30 jun. 2022 a.

11. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 339/2022. **Aprova novos regramentos para a adesão ao Modelo de Registro de Preços Compartilhado dos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, a ser realizado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e utilizado pelos municípios do Estado**. 21 dez. 2022 b.

12. BAHIA, Comissão Intergestores Bipartite. Resolução CIB nº 118/2024. **Aprova as normas para execução do financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito do Estado da Bahia.**. 12 abr. 2024.

13. BRASIL. **Decreto Presidencial nº 69.451 de 1º de novembro de 1971**. Disponível em: <https://planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/1970-1979/D69451impressao.htm>. Acesso em: 5 jun. 2024.

14. BRASIL. **Decreto Presidencial nº 71.205 de 04 de outubro de 1972**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-71205-4-outubro-1972-419927-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 jun. 2024.

15. BRASIL. Constituição Federal. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 5 out. 1988.

16. BRASIL. Lei nº 8.080/1990. **Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências**. 19 set. 1990.

17. BRASIL. Portaria GM/MS nº 3.916/1998. **Política Nacional de Medicamentos**. 30 out. 1998.

18. BRASIL. Portaria GM/MS nº 176/1999. **Estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e define valores a serem transferidos**. 8 mar. 1999.

19. BRASIL. **Incentivo a assistencia farmaceutica básica: o que é e como funciona.** Brasilia: Brasil. Ministerio da Saude, 2001.

20. BRASIL. **Lei nº 11.107/2005**. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm>. Acesso em: 15 out. 2024.

21. BRASIL. Portaria nº 1.555/2013. **Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**. 30 jul. 2013.

22. BRASIL. 06. Portaria de Consolidação nº 06/2017. **Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde**. 28 set. 2017 a.

23. BRASIL. 02. Portaria de Consolidação nº 02/2017. **Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.**. 28 set. 2017 b.

24. BRASIL. **Lei nº 14.133/2021**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm>. Acesso em: 11 set. 2024.

25. BRASIL. Portaria GM/MS nº 5.632/2024. **Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**. 25 out. 2024.

26. CONASEMS. **Reportagem especial 'Brasil, aqui tem SUS": Compra consorciada de medicamentos promove economia e amplia acesso em municípios mineiros**. Disponível em: <https://portal.conasems.org.br/noticias/570_reportagem-especial-brasil-aqui-tem-sus-compra-consorciada-de-medicamentos-promove-economia-e-amplia-acesso-em-municipios-mineiros>. Acesso em: 29 abr. 2025.

27. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Resolução CNS nº 338/2004**. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html>. Acesso em: 20 jun. 2024.

28. COSENDEY, Marly Aparecida Elias. **Análise da implantação do Programa Farmácia Básica: um estudo multicêntrico em cinco estados do Brasil**. Thesis—*[S.l.: S.n.]*.

29. DANIEL, Érika Albina; MURBACK, Fábio Guilherme Ronzelli. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DO USO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE. 2014.

30. DIBAI, Carolina Andrade Oliveira *et al.* Avaliação da eficiência na aquisição e distribuição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. **JORNAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA**, v. 8, n. 4, 22 nov. 2023.

31. EMMERICK, Isabel Cristina Martins. Avaliação da assistência farmacêutica no Brasil: um pensar sobre a abordagem de pesquisa proposta pela OMS e seus indicadores. 2006.

32. FALEIROS, Daniel Resende *et al.* Financing of Pharmaceutical Services in the municipal management of the Brazilian Unified Health System. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, p. 14s, 13 nov. 2017.

33. FERREIRA, Raissa Picanço *et al.* Financiamento da assistência farmacêutica no contexto do Sistema Único de Saúde de 2017 a 2022. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 2, p. e7213245023–e7213245023, 18 fev. 2024.

34. GIOVANELLA, Ligia *et al.* Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 1763–1776, jun. 2018.

35. INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. **Veículos leves 2024 - 16º Ciclo — INMETRO**. Disponível em: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/veiculos-automotivos-pbe-veicular/pbe-veicular-2024-1.pdf/view>. Acesso em: 12 jun. 2024.

36. LIMA, Shirley Barbosa Ortiz *et al.* Ferramentas da qualidade aplicadas à conferência do carro de emergência: pesquisa de métodos mistos. **Escola Anna Nery**, v. 25, p. e20200274, 7 out. 2020.

37. NACIONES UNIDAS. Resolucion 74/2. **Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal**. 10 out. 2019.

38. OLIVEIRA, Luciane Cristina Feltrin de; NASCIMENTO, Maria Angela Alves do; LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. O acesso a medicamentos em sistemas universais de saúde – perspectivas e desafios. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 286–298, 19 jun. 2020.

39. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Cobertura universal de saúde (CUS)**. Disponível em: <https://web-prod.who.int/world-health-day/world-health-day-2019/fact-sheets/details/universal-health-coverage-(uhc)>. Acesso em: 10 out. 2024.

40. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Avaliação da Assistência Farmacêutica no Brasil**. , 2005. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/avaliacao_assistencia_farmaceutica_estrutura_resultados.pdf>. Acesso em: 30 maio. 2024

41. PAIM, Jairnilson Silva. **O que é o SUS.** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015.

42. PONTES, Marcela Amaral *et al.* Aplicação de recursos financeiros para aquisição de medicamentos para atenção básica em municípios brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 2453–2462, ago. 2017.

43. SAÚDE, BRASIL Ministério da. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Rename 2022**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

44. SESAB, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. **Observatório Baiano de Regionalização**. Disponível em: <https://obr.saude.ba.gov.br/pri/desenhoTerritorial/pdr2007>. Acesso em: 17 out. 2024.

45. SILVA, Gabriele Santos da. Aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no estado do Rio de Janeiro (2017-2021). p. 203 f-203 f, 2022.

46. WHO, World Health Organization. **Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification**. Disponível em: <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>. Acesso em: 15 out. 2024.